CAPÍTULO

6

El paciente que no usa los alineadores

«Hacer bien vale más que hablar bien».

— BENJAMIN FRANKLIN

Hay situaciones en las que basta con observar los alineadores en boca para darse cuenta de que algo no está yendo como habíamos planeado, pero no todas las pérdidas de ajuste tienen el mismo significado y, sobre todo, no todas requieren la misma respuesta clínica.

Si un solo diente no sigue perfectamente el alineador, no pienso automáticamente que haya un problema de colaboración y no interrumpo necesariamente la secuencia para hacer un nuevo escaneo. Sabemos bien que algunos movimientos son menos predecibles que otros: un incisivo lateral superior que debe realizar una rotación compleja, una extrusión difícil u otro movimiento especialmente compli-

cado puede quedarse atrás incluso en un paciente que usa los alineadores de forma impecable. Si ese movimiento no es decisivo para continuar el tratamiento y el hecho de que no se produzca no compromete los movimientos posteriores, muchas veces prefiero seguir con la secuencia programada y corregirlo más adelante, durante la fase de refinamiento.

La situación cambia cuando la pérdida de ajuste deja de afectar a un solo diente y empieza a generalizarse. **Por eso, normalmente programo la primera revisión durante la secuencia al cabo de unos dos meses.** Considero que es un intervalo lo bastante largo para saber cómo está usando realmente el paciente los alineadores y empezar a observar una posible pérdida de ajuste, pero al mismo tiempo lo bastante breve para permitirme intervenir, en la mayoría de los casos, antes de que la discrepancia sea demasiado grande. Si en esa revisión veo que varios dientes empiezan a quedarse atrás respecto a la posición programada, a menudo todavía estamos a tiempo de recuperar el ajuste cambiando el comportamiento del paciente o ralentizando temporalmente la secuencia, sin tener que interrumpirlo todo y hacer un nuevo escaneo.

Cuando en esta primera revisión observo una pérdida de ajuste que ya no afecta a un solo movimiento, sino que va implicando progresivamente a más dientes, la sospecha de que el paciente no lleva los alineadores el número de horas necesario se vuelve inevitablemente muy fuerte. Es justo entonces cuando surge uno de los problemas de comunicación más frecuentes en el tratamiento con alineadores y, para entender qué está pasando, empiezo con una pregunta muy sencilla:

> *«¿Cómo va con los alineadores? ¿En qué momento del día te cuesta más volver a ponértelos?»*

Esta pregunta me ayuda más que un genérico *«¿Consigues llevarlos siempre?»*, al que el paciente tiende casi inevitablemente a responder que sí. Entonces intento reconstruir mejor lo que ocurre a lo largo de un día normal: le pregunto cuándo se los quita, cuánto duran las comidas, qué pasa durante el trabajo, cuando sale por la noche o durante el fin de semana. Presto especial atención al tiempo que transcurre entre el final de la comida y el momento en que vuelve a ponerse los alineadores, porque a menudo es ahí, más que durante la propia comida, donde se acumulan las horas sin ellos.

No lo hago como si fuera un interrogatorio, sino intentando averiguar junto con el paciente si hay momentos en los que, sin darse cuenta, pasa más tiempo sin alineadores del que cree. Al final, sin embargo, puede ocurrir que siga completamente seguro de su respuesta:

«No, doctor. De verdad que los llevo siempre».

En ese momento tengo ante mí dos datos que parecen difíciles de conciliar: por un lado, lo que observo clínicamente me indica que los dientes no están siguiendo los alineadores como deberían; por otro, tengo delante a una persona que me asegura con total convicción que ha seguido escrupulosamente todas las indicaciones recibidas.

El comportamiento que debemos cambiar

El comportamiento sobre el que queremos intervenir no es simplemente «*colaborar más*». Debemos conseguir que el paciente lleve los alineadores el número de horas necesario, reduciendo sobre todo esos periodos del día en los que pasan fuera de la boca más tiempo del que él mismo cree.

Esto es importante porque muchas veces el problema no nace de una decisión consciente de llevar poco los alineadores, sino de la suma de muchos intervalos aparentemente insignificantes: un desayuno que dura más de lo previsto, el café después de comer, una llamada antes de volver a ponérselos, un aperitivo, una cena que se alarga o, simplemente, dejarlos encima de la mesa y acordarse de ellos una hora después. Por separado parecen episodios sin importancia; sumados a lo largo del día pueden reducir considerablemente el tiempo real de uso.

Por eso, el primer objetivo no es determinar si el paciente dice la verdad, sino convertir un genérico «*los llevo siempre*» en una descripción lo bastante concreta de su día como para permitirnos entender dónde puede estar el problema.

El error que cometía: intentar convencer al paciente

Ante estas situaciones elegía lo que me parecía más sencillo y lógico. Si veía una pérdida generalizada de ajuste, le explicaba al paciente que probablemente no estaba llevando los alineadores el tiempo suficiente e insistía en que tenía que aumentar las horas de uso. Le mostraba lo que observaba clínicamente y le decía algo así:

«Mira, aquí se ve claramente que los dientes no están siguiendo los alineadores. Tienes que intentar llevarlos más tiempo».

El problema era que casi siempre recibía la misma respuesta:

«Pero si yo los llevo».

Yo veía la pérdida de ajuste e insistía, mientras que el paciente reiteraba que había seguido las indicaciones. Cuanto más intentaba convencerlo de que el problema era

su falta de colaboración, más necesidad sentía él de defender su comportamiento y, al cabo de unos minutos, ya no discutíamos cómo reconducir el tratamiento, sino cuál de los dos tenía razón.

Esta dinámica puede hacerse aún más evidente cuando tenemos delante a un paciente adulto muy seguro de sí mismo, quizá alguien con un puesto profesional importante, acostumbrado a tomar decisiones, dirigir a otras personas y defender con firmeza sus opiniones. Decirle abiertamente a ese paciente «*No es verdad, no estás llevando los alineadores*» significa cuestionar no solo su colaboración, sino también su credibilidad.

En ese momento, el problema clínico corre el riesgo de convertirse en un enfrentamiento personal en el que ambos intentamos, de forma más o menos consciente, demostrar que tenemos razón. La paradoja es que, aunque consiguiera ganar esa discusión, no habría logrado necesariamente lo que de verdad me importa, porque mi objetivo no debería ser convencer al paciente de que se ha equivocado durante las semanas anteriores, sino conseguir que lleve correctamente los alineadores de ahí en adelante.

Tardé un tiempo en entenderlo y, probablemente, necesité encontrarme con una paciente en particular para cambiar por completo de perspectiva.

La paciente a la que no creía

Había tratado con alineadores primero al marido de Chantal y después a sus dos hijos. Los tres habían colaborado mucho y sus tratamientos habían concluido sin especiales dificultades, así que, cuando ella también decidió arreglarse los dientes, no tenía ningún motivo para esperar algo distinto. El suyo era, al menos en apariencia, un caso muy sencillo, con algo de apiñamiento sobre todo en los incisivos inferiores y nada que, desde el punto de vista biomecánico, me hiciera prever dificultades especiales.

Empezamos el tratamiento y, ya en las primeras revisiones, me di cuenta de que algo no iba según lo previsto: los incisivos se movían mucho menos de lo que esperaba y los alineadores iban perdiendo ajuste. Ella trabajaba en el mundo de la moda, viajaba muchísimo y tenía una vida profesional especialmente intensa, llena de eventos, aperitivos y otros encuentros en los que es fácil olvidarse de los alineadores. Por eso, para mí, la explicación parecía casi obvia: sencillamente, no los llevaba el tiempo suficiente.

Empecé entonces a insistir en que debía colaborar, recordándole que tenía que llevar los alineadores el número de horas prescrito y explicándole que, si seguía

así, los dientes no se moverían conforme a lo planificado. Ella, sin embargo, seguía repitiéndome lo mismo:

«Enzo, yo los llevo».

Yo seguía mirando aquellos incisivos y seguía sin creerla. La situación se prolongó durante más de seis meses, hasta que Chantal me dijo que al cabo de unos meses se trasladaría a Londres por trabajo y me pidió que termináramos el tratamiento antes de que se marchara. Entonces pensé en eliminar de una vez por todas lo que, para mí, seguía siendo la causa principal del problema y le propuse colocarle brackets en los incisivos inferiores, prometiéndole que en un par de meses estarían perfectamente alineados. Estaba bastante tranquilo, porque estaba convencido de que, una vez eliminada la variable de la colaboración, aquellos pocos dientes se alinearían rápidamente.

Después de dos meses, los incisivos seguían torcidos.

Fue probablemente la primera vez que consideré de verdad una posibilidad que hasta entonces casi había descartado: quizá aquella paciente nunca me había mentido y el problema que durante meses había atribuido a su falta de colaboración podía deberse, al menos en parte, a su respuesta biológica al movimiento ortodóncico.

Los dientes no se mueven a la misma velocidad en todos los pacientes

Aquella experiencia me llevó a interesarme más por la variabilidad individual del movimiento ortodóncico y descubrí que lo que había observado clínicamente tenía una base biológica mucho más sólida de lo que imaginaba.

Cuando aplicamos una fuerza ortodóncica, en realidad no estamos desplazando mecánicamente un diente como desplazaríamos un objeto. La fuerza es el estímulo inicial de una compleja respuesta biológica en la que intervienen el ligamento periodontal, el hueso alveolar, los osteoclastos, los osteoblastos, los mediadores de la inflamación y numerosos mecanismos celulares y moleculares. La velocidad a la que se produce esta respuesta presenta una considerable variabilidad individual y, aunque intentemos estandarizar la fuerza aplicada, distintas personas pueden mostrar velocidades de movimiento muy diferentes.

Uno de los estudios que mejor demuestra este fenómeno lo publicaron Giannopoulou y sus colaboradores en el *European Journal of Orthodontics*. Los autores aplicaron un protocolo experimental estandarizado en el que se desplazaron en sentido vestibular dos premolares de cada participante durante ocho semanas con

una fuerza de 1 N. Pese a que la fuerza estaba estandarizada y se habían descartado obstáculos locales o funcionales para el movimiento, la magnitud del desplazamiento varió enormemente entre individuos: desde apenas 0,6 mm hasta 5,8 mm, con una media de 2,7 mm. Aún más interesante fue observar que los dientes de un mismo individuo tendían a comportarse de forma similar, con una elevada correlación intraindividual. Los propios autores concluyeron que esta amplia variabilidad permitía identificar, dentro de la muestra, sujetos *slow movers* y *fast movers*.

El concepto se ha retomado también en estudios clínicos posteriores. En un ensayo aleatorizado sobre el cierre de espacios tras extracciones, por ejemplo, los autores utilizaron expresamente las expresiones *fast movers* y *slow movers* para distinguir a pacientes que, en un mismo intervalo de tiempo, presentaban distintas magnitudes de movimiento dentario. En ese estudio concreto, se definió como *fast movers* a los casos con un movimiento de al menos 1 mm al mes. Naturalmente, este umbral no es una definición universal que podamos trasladar a la práctica clínica ni nos permite dividir sin más a todos nuestros pacientes en dos categorías, pero demuestra hasta qué punto la idea de que la velocidad de movimiento varía de una persona a otra es real y se utiliza en la propia literatura ortodóncica.

Las causas de esta variabilidad probablemente son múltiples y aún no se conocen por completo. El movimiento ortodóncico depende de la respuesta biológica de los tejidos a la fuerza y se han estudiado diferencias individuales en los sistemas moleculares que intervienen en la remodelación ósea y del ligamento periodontal. Algunas investigaciones también han analizado la posible contribución genética y, en particular, polimorfismos de genes implicados en los sistemas RANK, RANKL y OPG y en otros mediadores de la respuesta ortodóncica. Es interesante que, también en este ámbito, los autores hagan referencia explícita al fenómeno clínico de los *slow movers* y los *fast movers*, y planteen la hipótesis de que al menos parte de la diferencia en la velocidad de movimiento pueda deberse a las características biológicas de cada individuo.

Esta variabilidad biológica, naturalmente, también existía cuando realizábamos los tratamientos con aparatología fija. En ese contexto, sin embargo, un *slow mover* suponía sobre todo un problema de tiempo. Si un diente aún no había alcanzado la posición deseada, en la mayoría de los casos podíamos simplemente dejar actuar el mismo arco más tiempo y esperar a que la respuesta biológica siguiera su curso. Como siempre me ha dicho mi gran maestro Davide Mirabella: «*Let them cook*». Déjalos cocinar. A veces, lo mejor era simplemente dar a los dientes el tiempo necesario para que se produjera el movimiento.

Que aquel paciente necesitara más tiempo no nos obligaba necesariamente a modificar la secuencia del tratamiento: podíamos adaptar el ritmo del tratamiento a la velocidad a la que realmente se movían sus dientes.

Con los alineadores, el problema adquiere otra dimensión, porque ya no se trata solo de cuánto tarda el diente en moverse, sino de hasta qué punto su velocidad biológica puede mantenerse sincronizada con la secuencia programada. Cada alineador se diseña dando por supuesto que el movimiento previsto por el alineador anterior se ha producido en grado suficiente. Si el paciente es un *slow mover* y seguimos cambiando los alineadores a un ritmo demasiado rápido para su respuesta biológica, el diente puede ir quedándose atrás respecto a la posición prevista. El siguiente alineador intenta entonces ajustarse a una posición que el diente aún no ha alcanzado y esa discrepancia, cambio tras cambio, puede acumularse hasta hacerse clínicamente evidente en forma de pérdida de ajuste.

Esta es probablemente una de las razones por las que el concepto de *slow mover*, aunque no es en absoluto nuevo, cobra especial relevancia en el tratamiento con alineadores. Con la aparatología fija, a menudo podíamos permitirnos simplemente esperar más tiempo; con los alineadores, en cambio, debemos intentar acompasar el ritmo al que avanzamos en la secuencia con la velocidad a la que la respuesta biológica de ese paciente permite realmente que se produzca el movimiento.

Naturalmente, todo esto no significa que una pérdida generalizada de ajuste deba atribuirse automáticamente a la biología, ni que ser un *slow mover* sea la explicación más probable cada vez que un tratamiento con alineadores no avanza según lo previsto. La colaboración sigue siendo una de las primeras variables que debemos tener en cuenta cuando varios dientes empiezan a perder ajuste a la vez. Sin embargo, la literatura sobre los *slow movers* nos recuerda algo igual de importante: la observación clínica por sí sola no siempre nos permite saber con certeza hasta qué punto lo que vemos se debe al comportamiento del paciente y hasta qué punto puede influir su respuesta biológica individual.

Al final, Chantal me había enseñado precisamente eso. En su caso, había eliminado la variable de la colaboración al pasar a la aparatología fija y los dientes habían seguido moviéndose lentamente: **realmente era una *slow mover*.** Pero aquella experiencia también me hizo entender otra cosa. Si una respuesta biológica más lenta podía explicar realmente una pérdida de ajuste, también podía recurrir a esa posibilidad clínica cuando tenía delante a un paciente del que sospechaba firmemente que, en realidad, el problema era la colaboración, sin tener que acusarlo ni demostrar que lo que me contaba no se correspondía con lo que hacía en realidad.

De ahí surgió, con los años, una de las estrategias que utilizo con más frecuencia.

No tengo que demostrar que el paciente miente

Hoy, cuando veo a un paciente con una pérdida generalizada de ajuste, ya no empiezo acusándolo ni intento convencerlo de inmediato de que no está llevando los alineadores. Primero intento reconstruir con él lo que está ocurriendo, repasando sus hábitos diarios y buscando posibles momentos en los que los alineadores pasan fuera de la boca más tiempo del que el propio paciente cree. Este paso también es importante por todo lo que hemos visto en la primera parte del libro sobre la memoria reconstructiva y la diferencia que puede existir entre el comportamiento real y la forma en que cada uno de nosotros recuerda y cuenta su propio comportamiento.

Si, después de esta conversación, el paciente sigue asegurándome que lleva los alineadores exactamente como se le ha indicado, ya no intento demostrarle lo contrario, sino que decido deliberadamente aceptar su versión e introduzco otra posible explicación:

> «*Mira, tenemos dos datos que debemos encajar. Yo veo que tus dientes no siguen los alineadores a la velocidad que habíamos previsto y tú me dices que los estás llevando correctamente. Si es así, tenemos que considerar otra posibilidad*».

Normalmente, en este punto el paciente presta mucha atención, porque no se siente acusado y quiere entender cuál puede ser esa otra explicación. Continúo:

> «*Los dientes no se mueven a la misma velocidad en todas las personas. La mayoría de los pacientes responde en los plazos que solemos utilizar, pero hay un pequeño porcentaje de personas cuya respuesta biológica es mucho más lenta. En la literatura también se utilizan los términos fast movers y slow movers. Si de verdad estás llevando los alineadores como me dices y los dientes siguen quedándose atrás, tenemos que considerar la posibilidad de que seas un slow mover*».

En este punto no he contradicho al paciente ni le he pedido que admita nada. Al contrario, he dado por buena su versión de los hechos, pero precisamente porque la he aceptado debo extraer de ella una consecuencia clínica coherente:

> «*Si tus dientes se mueven más despacio, puede que una semana no sea suficiente para que sigan por completo el movimiento programado en cada alineador. Si aun así siguiéramos cambiándolos cada siete días, correríamos el riesgo de acumular progresivamente un retraso entre la posición prevista y la posición real de los dientes, empeorando cada vez más el ajuste*».

La consecuencia que planteo es sencilla:

«Por eso, al menos de momento, en vez de cambiar de alineador cada semana deberíamos hacerlo cada tres semanas. Después comprobaremos cómo están respondiendo los dientes y, si vemos que el ajuste mejora, podremos probar a acelerar progresivamente y pasar, por ejemplo, a cambiarlo cada dos semanas».

El cambio cada tres semanas es una decisión clínica prudente por mi parte, no un intervalo que la literatura haya identificado como necesario para todos los pacientes con una respuesta biológica más lenta. Para el paciente, sin embargo, pasar de siete a veintiún días hace inmediatamente concreta una consecuencia que hasta entonces podía haberle parecido abstracta: si necesitáramos tres veces más tiempo del previsto para cada alineador, de mantener ese ritmo, la duración total del tratamiento podría llegar a triplicarse.

Y es precisamente en ese momento cuando, muy a menudo, ocurre lo más interesante.

El paciente se queda pensándolo unos segundos y empieza espontáneamente a reconstruir su comportamiento de otra manera:

«Bueno, doctor, la verdad es que veintidós horas todos los días, quizá no. Los fines de semana a veces los llevo menos y, cuando salgo, puede que esté más tiempo sin ellos. Si me esfuerzo de verdad por llevarlos siempre, ¿podemos seguir cambiándolos cada semana?».

Es importante entender que no le he pedido que confiese nada. No le he dicho que no le creo ni he intentado demostrar que me estuviera mintiendo. Simplemente he tomado en serio lo que me contaba y le he mostrado cuál sería la consecuencia clínica lógica si de verdad, pese a llevarlos correctamente, sus dientes no pudieran seguir el ritmo programado.

En cuanto entiende que eso podría significar pasar de siete a veintiún días y, por tanto, alargar enormemente el tratamiento, también cambia su forma de valorar esas horas sin alineadores. Lo que hasta unos minutos antes resumía con *«los llevo siempre»* puede convertirse en *«la verdad es que los fines de semana los llevo un poco menos»*, o en *«cuando salgo, a veces estoy bastante tiempo sin ellos»*.

Y, cuando eso ocurre, en la mayoría de los casos **no paso a cambiarlos cada tres semanas**. Si el paciente reconoce espontáneamente que los ha llevado menos horas de las prescritas y me dice que quiere intentar ser más riguroso, mantengo el cambio semanal y le doy la oportunidad de demostrarlo con lo que ocurra en las semanas siguientes. En cambio, el cambio cada tres semanas sigue siendo la consecuencia clínica lógica cuando el paciente continúa asegurándome que ha llevado correctamente los alineadores.

En otras palabras, no utilizo la ralentización como castigo. Utilizo el Tiempo para hacer concreta la consecuencia de lo que estoy observando y permitir que el paciente decida si cambia su comportamiento.

En esta fase, la palanca más poderosa es el Tiempo

Como ya he explicado, el Tiempo, el Resultado y la Inversión son tres de las palancas que utilizo con más frecuencia al comunicarme durante un tratamiento con alineadores, pero no todas tienen el mismo peso en cada momento del tratamiento.

Cuando el paciente lleva solo unos meses de tratamiento, recurrir a la palanca de la Inversión suele tener poco sentido, porque el tratamiento acaba de empezar y el paciente acaba de afrontar su coste económico. El Resultado también sigue siendo importante, por supuesto, pero en esta fase aún puede parecerle relativamente lejano y al paciente puede costarle percibir hasta qué punto una colaboración insuficiente hoy puede poner en peligro algo que no verá hasta dentro de muchos meses. El Tiempo, en cambio, se entiende de inmediato.

Si una persona ha comenzado un tratamiento sabiendo que cambiaría de alineador cada semana y que duraría aproximadamente quince o dieciocho meses, oír que a partir de ese momento quizá tenga que llevar cada alineador durante tres semanas hace que la consecuencia resulte muy concreta. Ya no hablamos en términos generales de la posibilidad de que *«el tratamiento se alargue»*: el paciente ve enseguida que el ritmo al que avanza podría ser tres veces más lento de lo que había imaginado al principio.

Por eso le explico:

> *«Inevitablemente, tenemos que contar con que el tratamiento pueda alargarse mucho. Si tus dientes de verdad necesitan dos o tres veces más tiempo para seguir cada alineador, no podemos esperar que el tratamiento dure lo que habíamos previsto al principio. Primero tenemos que averiguar a qué ritmo pueden seguir realmente tus dientes los alineadores y después podremos hacer una previsión más fiable».*

No necesito decirle al paciente que un tratamiento de dieciocho meses durará sin duda cuatro años y medio, porque no puedo saberlo y no sería correcto convertir una posible consecuencia en una previsión segura. Pero sí puedo hacerle entender que, **si el ritmo siguiera siendo realmente de un alineador cada tres semanas en vez de cada siete días, el tiempo necesario podría llegar a ser incluso tres veces mayor**.

Y es precisamente la diferencia entre una consecuencia genérica y una concreta lo que hace tan eficaz la palanca del Tiempo. Decir *«si no los llevas, el tratamiento durará más»* es algo que el paciente probablemente ya ha oído y que puede resultarle completamente abstracto. Pasar de siete a veintiún días, en cambio, significa traducir esa misma consecuencia en algo que puede ver, medir y relacionar con su propio objetivo.

Una estrategia que funciona en ambos casos

Lo que más me interesa de este enfoque es que no necesito saber con absoluta certeza cuál de las dos explicaciones es la correcta.

Si el paciente lleva realmente los alineadores veintidós horas al día y tiene una respuesta biológica especialmente lenta, espaciar los cambios y volver a evaluar el ajuste es una decisión prudente y coherente con lo que observo clínicamente.

Si, en cambio, como probablemente ocurre en la mayoría de las situaciones en las que utilizo esta estrategia, el paciente lleva los alineadores muchas menos horas de las que dice, no lo he acusado de mentir ni lo he obligado a defenderse. Simplemente le he mostrado una consecuencia de su comportamiento actual que para él tiene una importancia inmediata.

Muy a menudo, eso es precisamente lo que lo lleva a revisar espontáneamente su versión. El paciente no necesita pasar bruscamente de *«los llevo siempre»* a *«te estaba mintiendo»*. Puede simplemente detenerse, repasar mentalmente su semana y reconocer que quizá ese *siempre* no significaba realmente veintidós horas cada día. Si entonces decide esforzarse más, puedo mantener el cambio semanal y comprobar si a sus palabras les sigue de verdad un comportamiento distinto.

Si, por el contrario, sigue sosteniendo que ya los lleva las horas indicadas, no tengo motivo para discutir: acepto esa explicación, espacio los cambios y compruebo la respuesta.

En ambos casos he conseguido lo que de verdad me interesaba: **una decisión concreta sobre lo que ocurrirá a partir de ese momento.**

La confesión no mueve los dientes

Creo que este ha sido uno de los cambios más importantes en mi forma de comunicarme con los pacientes poco colaboradores. Durante mucho tiempo pensé que mi tarea era conseguir que el paciente entendiera que no estaba haciendo lo que le había pedido, casi como si admitir el error fuera una condición necesaria para

poder retomar bien el tratamiento. Con el tiempo, sin embargo, comprendí que conseguir esa admisión no era en absoluto lo que necesitaba.

Paradójicamente, hoy esa especie de confesión llega con más frecuencia precisamente porque he dejado de buscarla. Cuando el paciente no se siente acusado y entiende, en cambio, la consecuencia concreta de lo que estamos observando, puede permitirse reconsiderar su comportamiento sin vivir ese cambio de versión como una derrota.

Si me dice «*La verdad es que los fines de semana los he llevado menos, pero a partir de hoy voy a esforzarme de verdad*», esa información sin duda me resulta útil, porque me permite mantener el cambio semanal y comprobar si una mejor colaboración basta para recuperar el ajuste. Pero no es la confesión lo que tiene valor terapéutico: es lo que el paciente haga después.

Si, en cambio, después de diez minutos de discusión consiguiera obligarlo a admitir «*Tienes razón, en realidad los llevaba doce horas al día*», quizá tendría la satisfacción de saber que había interpretado correctamente el ajuste, pero desde el punto de vista clínico aún no habría conseguido lo que de verdad me interesa. **La confesión no mueve los dientes; un cambio de comportamiento, sí.**

La estrategia del *slow mover* permite al paciente cambiar su comportamiento sin obligarlo a admitir que lo que me había contado hasta unos minutos antes no era del todo cierto. Le ofrece la posibilidad de salvar la cara, pero al mismo tiempo le hace mucho más difícil ignorar la consecuencia de seguir actuando igual.

Si ponemos a una persona en la tesitura de elegir entre admitir que no ha seguido nuestras indicaciones y continuar defendiendo su versión, puede elegir la segunda opción aunque eso no la ayude en absoluto a conseguir el resultado que desea. Si, en cambio, evitamos esa discusión y centramos la atención en las consecuencias clínicas y las posibles soluciones, le permitimos cambiar de comportamiento sin tener que reconocer abiertamente antes que se ha equivocado.

Por eso, cuando los datos clínicos y lo que cuenta el paciente no coinciden, hoy intento mucho menos establecer quién tiene razón y mucho más encontrar una estrategia que pueda funcionar independientemente de cuál sea la explicación. **No necesitamos demostrarle al paciente que tenemos razón; necesitamos crear las condiciones para que pueda empezar a hacer lo correcto.**

GUION OPERATIVO

Cuando observo una pérdida generalizada de ajuste, después de repasar con el paciente sus hábitos y de que me confirme que lleva correctamente los alineadores, puedo plantear la conversación así:

> *«Veo que varios dientes no están siguiendo los alineadores al ritmo que habíamos previsto. Hemos repasado juntos cómo los llevas y me confirmas que lo haces correctamente, así que tenemos que considerar otra posibilidad. Los dientes no se mueven a la misma velocidad en todas las personas y hay pacientes cuya respuesta biológica al movimiento ortodóncico es más lenta. En la literatura también se utilizan los términos fast movers y slow movers y, si realmente llevas los alineadores como me dices, es posible que pertenezcas a este segundo grupo.*
>
> *Si tus dientes se mueven más despacio, puede que una semana no baste para que alcancen del todo la posición prevista por cada alineador. Si siguiéramos cambiándolos cada siete días, ese pequeño retraso podría acumularse y el ajuste empeoraría cada vez más. Por eso, si de verdad los llevas las horas que me has indicado, tenemos que dar más tiempo a los dientes y pasar, al menos al principio, de una semana a tres semanas con cada alineador.*
>
> *Eso significa que el tratamiento avanzaría a un ritmo tres veces más lento. No puedo decirte hoy que todo el tratamiento vaya a durar tres veces más, porque primero tenemos que ver cómo responden los dientes y quizá podamos volver a acelerar, pero, si tuviéramos que mantener ese ritmo durante todo el tratamiento, la duración total también podría aumentar mucho. Ahora tenemos que averiguar a qué ritmo pueden seguir realmente tus dientes los alineadores».*

En ese momento dejo hablar al paciente. Si me dice:

> *«Doctor, la verdad es que quizá no siempre son veintidós horas. Si me esfuerzo de verdad, ¿podemos intentar mantener el cambio semanal?».*

Mi respuesta puede ser igual de sencilla:

> *«Claro. Si crees que hay horas que podemos recuperar, prefiero darte esa oportunidad. Seguiremos con el cambio semanal, pero a partir de hoy tenemos que ser muy rigurosos. En la próxima revisión, el ajuste nos dirá si ese cambio ha sido suficiente».*

Si, por el contrario, sigue confirmándome que ya los lleva las horas indicadas, no insisto ni intento hacerle cambiar de versión: espacio los cambios como le he explicado y compruebo después cómo responde.

Por qué funciona este protocolo

- **Reducción de la reactancia**

Contradecir directamente al paciente y decirle que no está llevando los alineadores como afirma puede llevarlo a defender aún más su postura. Aceptar de entrada su versión y proponer una explicación alternativa evita el enfrentamiento y mantiene la conversación centrada en resolver el problema.

- **Salvar la cara**

La estrategia del *slow mover* permite al paciente que ha llevado poco los alineadores cambiar su comportamiento sin verse obligado a admitir que ha mentido. Puede simplemente reconsiderar qué quería decir con «*siempre*» y reconocer que ha habido horas en las que no los ha llevado. Así, cambiar de comportamiento no exige pasar antes por una derrota personal.

- **Saliencia de la consecuencia**

Decir «*tienes que llevarlos más*» indica lo que debería hacer, pero no le muestra necesariamente por qué debería hacerlo. Pasar de siete a veintiún días, en cambio, convierte la consecuencia en algo que se entiende de inmediato.

- **La palanca del Tiempo**

En las primeras fases del tratamiento, el paciente acaba de afrontar la Inversión y el Resultado final aún puede quedarle lejos, mientras que el Tiempo representa una consecuencia cercana y fácil de entender. La perspectiva de avanzar a un ritmo tres veces más lento puede cambiar rápidamente el valor que atribuye a esas horas en las que no lleva los alineadores.

- **Información para evaluar la respuesta**

El protocolo no termina con la conversación. Si el paciente decide mantener el cambio semanal y se compromete a esforzarse más, el ajuste en la siguiente revisión nos permite comprobar si ese cambio de comportamiento ha sido suficiente. Si, por el contrario, espaciamos los cambios y el ajuste sigue sin mejorar, también debemos estar dispuestos a reconsiderar nuestra hipótesis clínica.

BIBLIOGRAFÍA

Giannopoulou C, Dudic A, Pandis N, Kiliaridis S. Slow and fast orthodontic tooth movement: an experimental study on humans. *European Journal of Orthodontics.* 2016;38(4):404-408.

Bertl K, Neuner H, Meran A, et al. Does the time-point of orthodontic space closure initiation after tooth extraction affect the incidence of gingival cleft development? A randomized controlled clinical trial. *Journal of Periodontology.* 2020;91(5):572-581.

Küchler EC, Schröder A, Corso P, et al. Genetic polymorphisms influence gene expression of human periodontal ligament fibroblasts in the early phases of orthodontic tooth movement. *Odontology.* 2020;108:493-502.

Adaptar la comunicación al perfil DISC

D

Dominante

Palanca principal: tiempo y control.

Con un paciente Dominante evitaría el enfrentamiento directo, porque cuestionar abiertamente lo que nos cuenta podría convertir rápidamente la conversación en un pulso. Es más eficaz presentar las dos posibilidades con claridad y dejar que su comportamiento posterior determine qué camino podremos seguir.

> *«Si ya los llevas las horas indicadas, tenemos que espaciar los cambios porque tus dientes necesitan más tiempo. Si, en cambio, crees que puedes ser más riguroso, podemos mantener el cambio semanal y comprobar enseguida si recuperamos el ajuste. En la próxima revisión tendremos la respuesta».*

I

Influyente

Palanca principal: resultado y motivación.

Con un paciente Influyente evitaría una explicación demasiado larga o técnica y me centraría más en la posibilidad de reconducir rápidamente la situación y mantener el ritmo inicial si consigue cambiar de verdad su comportamiento.

> *«Todavía podemos intentar mantener el cambio semanal. Si sabes que algunos días los has llevado menos, a partir de hoy recuperamos esas horas y vemos cómo responden los dientes. Si en la próxima revisión hemos recuperado el ajuste que buscamos, seguimos así».*

S

Estable

Palanca principal: tranquilidad y seguimiento.

Con un paciente Estable es importante evitar que interprete la situación como una señal de que el tratamiento está fracasando. Le explicaría, por tanto, que tenemos dos caminos posibles y que podemos hacer un seguimiento de ambos.

> *«No significa que el tratamiento no esté funcionando. Solo tenemos que averiguar si los dientes necesitan más tiempo o si podemos recuperar algunas horas de uso. Si crees que puedes ser más riguroso, de momento mantenemos el cambio semanal y en la próxima revisión vemos juntos cómo están respondiendo».*

Adaptar la comunicación al perfil DISC

CONTINÚA

C

Concienzudo

Palanca principal: datos y explicación.

Con un paciente Concienzudo me apoyaría más en lo que podemos observar clínicamente: le mostraría el ajuste y le explicaría con precisión las dos hipótesis y cómo la siguiente revisión nos permitirá distinguir entre ellas.

> «*Clínicamente vemos que los dientes se han quedado atrás con respecto a la posición prevista. Si ya los llevas las horas indicadas, tenemos que considerar que la respuesta biológica sea más lenta y aumentar el tiempo de uso de cada alineador. Si, en cambio, crees que ha habido horas en las que no los has llevado, podemos mantener por ahora el cambio semanal, corregir eso y comprobar en la próxima revisión si la discrepancia se reduce*».

CAPÍTULO 6

Resumen del protocolo

CUÁNDO APLICARLO	En la primera revisión de la secuencia, normalmente al cabo de unos dos meses, cuando aparece una pérdida progresiva y generalizada de ajuste. Valorar también la planificación y la respuesta biológica antes de atribuirla a la colaboración del paciente.
OBJETIVO	Recuperar el ajuste modificando el comportamiento o el intervalo entre cambios y comprobando la respuesta.
QUÉ HACER	1. Repasar cómo transcurre el día: comidas, trabajo, salidas nocturnas, fines de semana y tiempo que tarda en volver a ponerse los alineadores. 2. Si el paciente confirma que los lleva correctamente, considerar también una respuesta biológica más lenta. 3. Plantear el paso de siete a veintiún días y explicar que ralentizaría considerablemente el tratamiento. Los veintiún días son una elección del protocolo descrito, no una pauta universal. 4. Si reconoce que no los lleva lo suficiente, acordar que cumpla las horas prescritas y mantener el cambio semanal cuando las condiciones clínicas lo permitan. 5. Si confirma que los lleva correctamente, espaciar los cambios y volver a evaluar el ajuste para decidir después si mantener ese ritmo o acelerar. 6. Si el ajuste no mejora, reconsiderar también la hipótesis clínica inicial.
QUÉ COMPROBAR	Distribución de la pérdida de ajuste, horas y rutina de uso, intervalo entre cambios y respuesta en la siguiente revisión. Una promesa de esforzarse más debe ir seguida de un cambio comprobable.